

Số: 537 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc chống ung thư KPEC 500

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc KPEC 500. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: thuốc có hoạt chất là capecitabine 500mg một dẫn xuất của fluoropyrimidine carbamate, là thuốc độc tế bào được hoạt hóa bởi khối u và chọn lọc trên khối u.
- Cơ chế tác dụng:
Capecitabine không có tác dụng dược lý cho đến khi chuyển thành 5-FU, ở tế bào lành và tế bào ung thư 5-FU được chuyển hóa thành 5-fluoro-2'-deoxyuridin 5'-monophosphat (FdUMP) và 5-fluorouridin triphosphate (FUTP):
 - FdUMP và đồng yếu tố folat gắn vào thymidylate synthase để tạo ra phức hợp bậc ba dẫn đến ức chế sự tạo thành thymidylate từ 2'-deoxyuridylat. Thymidylat là tiền chất của thymidine triphosphate – một dẫn chất cần thiết để tổng hợp DNA do đó sự thiếu hụt thymidylate dẫn đến ức chế phân chia tế bào;
 - FUTP có thể gắn vào RNA thay cho uridin triphosphate, tạo ra RNA sai lạc nên ảnh hưởng lên quá trình xử lý RNA và sự tổng hợp protein.
- Dạng bào chế: viên nén bao phim (màu hồng, hình bầu dục).

2. Chỉ định và liều dùng

Chỉ định	Liều dùng	
Ung thư vú	Đơn trị	1.250mg/m ² diện tích bề mặt cơ thể, uống 2 lần mỗi ngày (tương đương 2500mg/m ² tổng liều mỗi ngày) trong 14 ngày sau đó là 7 ngày ngưng thuốc, nên uống với nước trong vòng 30 phút sau khi ăn.
	Điều trị kết hợp	Khởi đầu 1.250mg/m ² x2 lần/ngày trong 2 tuần sau đó là 1 tuần ngưng

		thuốc, kết hợp với docetaxel 75mg/m ² truyền tĩnh mạch trong vòng 1 giờ mỗi 3 tuần.
Ung thư đại tràng, trực tràng	Đơn trị	1.250mg/m ² diện tích bề mặt cơ thể, uống 2 lần mỗi ngày (tương đương 2500mg/m ² tổng liều mỗi ngày) trong 14 ngày sau đó là 7 ngày ngưng thuốc.
Ung thư dạ dày – thực quản, Ung thư đại tràng, trực tràng	Điều trị kết hợp	Capecitabine 800-1000mg/m ² x 2 lần/ngày trong 2 tuần sau đó 7 ngày ngưng thuốc hoặc 625mg/m ² x 2 lần/ngày khi điều trị liên tục.

Đối với các trường hợp đặc biệt xem thêm ở tờ HDSD đi kèm.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với capecitabine hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Bệnh nhân có tiền sử phản ứng nghiêm trọng và không đoán trước với fluoropyridine hoặc được biết là quá mẫn với fluorouracil;
- Bệnh nhân có thiếu hụt DPD;
- Không nên dung capecitabine cùng với sorivudin hoặc các chất tương tự có liên quan về mặt hóa học như brivudine;
- Bệnh nhân suy gan nặng (Child Push C);
- Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải creatinine giảm dưới 30ml/phút);
- Phụ nữ có thai và cho con bú;
- Bệnh nhân giảm bạch cầu, bạch cầu trung tính, tiểu cầu nặng;
- Nếu có chống chỉ định với bất kỳ thuốc nào trong phác đồ kết hợp thì không nên dùng thuốc đó.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCIL. NGUYỄN VĂN ĐỐI**